

Quiste Renal Simple y Riñón Poliquístico

La hematuria se define como la presencia de sangre en la orina, específicamente la detección de **3 o más glóbulos rojos por campo de mayor aumento** en el sedimento urinario. Su estudio debe ser sistemático y ordenado para descartar patologías que van desde procesos benignos (como una infección) hasta condiciones potencialmente letales como neoplasias malignas.

Paso 0: Anamnesis y Examen Físico

Todo estudio comienza con una historia clínica detallada. La anamnesis nos permite orientar la etiología antes de solicitar exámenes complejos.

- **Dolor:** La hematuria dolorosa suele asociarse a **Litiasis Renal** o infecciones. La hematuria **indolora o monosintomática** es la "red flag" principal para cáncer.
- **Edad y Factores de Riesgo:** En pacientes mayores de 40-50 años, el tabaquismo y la exposición a químicos industriales aumentan la sospecha de **Cáncer de Vejiga**.
- **Síntomas acompañantes:** Fiebre, disuria y poliaquiuria orientan a una **Infección del Tracto Urinario** (ITU). Edema e hipertensión sugieren una causa glomerular.
- **Uso de fármacos:** Algunos medicamentos (como la rifampicina o nitrofurantoína) o alimentos (betarragas) pueden causar **pseudohematuria**.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología del Dismorfismo: Los glóbulos rojos de origen glomerular sufren daño estructural al atravesar la barrera de filtración y los túbulos renales (cambios osmóticos y mecánicos), lo que genera formas irregulares (acantocitos). Los glóbulos rojos de origen urológico (vía urinaria baja) mantienen su forma circular normal (isomórficos).

Paso 1: Sedimento de Orina y Urocultivo

Este es el primer peldaño del estudio diagnóstico. Su objetivo es doble: confirmar la hematuria y diferenciar entre una causa nefrológica (glomerular) o urológica.

- **Confirmación:** El sedimento confirma que los pigmentos detectados en la tira reactiva son efectivamente eritrocitos y no hemoglobina libre o mioglobina.
- **Descarte de causas frecuentes:**
 - **Infección del Tracto Urinario (ITU):** Si el sedimento muestra leucocituria y el urocultivo es positivo, se inicia tratamiento antibiótico y se reevalúa tras finalizarlo.
 - **Glomerulonefritis:** Se sospecha ante una **hematuria dismórfica**, presencia de cilindros hemáticos y proteinuria significativa. En este caso, el manejo debe ser derivado a **Nefrología**.

Diferenciación Clínica de la Hematuria

TABLA 3.14.1: CARACTERÍSTICA VS HEMATURIA GLOMERULAR (NEFROLÓGICA)		
CARACTERÍSTICA	HEMATURIA GLOMERULAR (NEFROLÓGICA)	HEMATURIA NO GLOMERULAR (UROLÓGICA)
Color	Café, pardo o "color coca-cola"	Rojo rutilante, rosado
Coágulos	Siempre ausentes	Pueden estar presentes
Morfología GR	Dismórficos (Acantocitos >5%)	Isomórficos (Normales)
Cilindros	Hemáticos (Patognomónicos)	Ausentes
Proteinuria	Frecuente y marcada	Mínima o ausente

Paso 2: Estudio de Imágenes

Si la hematuria persiste, no hay infección y no hay signos de enfermedad glomerular, el siguiente paso es evaluar la anatomía del sistema urinario buscando cálculos, quistes o tumores.

- **Ecografía Renal y Vesical:** Es el examen de entrada mínimo. Es útil para detectar cálculos grandes, hidronefrosis y masas renales evidentes.
- **Uro-TAC (Pielotac):** Es el **estándar de oro** para el estudio de hematuria de origen urológico. Consiste en una tomografía con protocolo específico que incluye una fase de eliminación (excretora). El medio de contraste permite "dibujar" toda la vía urinaria (cálices, uréteres y vejiga), siendo altamente sensible para detectar cáncer renal y tumores uroteliales.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el EUNACOM, ante un paciente adulto mayor, fumador, con hematuria total, indolora y sin infección, la sospecha principal debe ser **Cáncer de Vejiga**.

Paso 3: Cistoscopia

La cistoscopia es la evaluación de última línea y es fundamental para el diagnóstico del **Cáncer de Vejiga**.

- **Indicación:** Se solicita cuando los estudios anteriores son negativos o cuando hay factores de riesgo elevados de malignidad, ya que la ecografía y el TAC pueden pasar por alto tumores vesicales pequeños o planos (carcinoma in situ).
- **Utilidad:** Permite la visualización directa de la mucosa vesical y la toma de biopsias.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La **hematuria monosintomática** en el adulto debe completarse siempre con estudio de imágenes y, en la mayoría de los casos, cistoscopia, especialmente si existen factores de riesgo. No se debe atribuir a "hiperplasia prostática" sin antes descartar cáncer.

Manejo de la Hematuria Grave (Urgencia)

Existen situaciones donde la hematuria es tan severa que pone en riesgo la estabilidad del paciente o la permeabilidad de la vía urinaria (por formación de coágulos).

- **Signo de Alarma:** Presencia de **coágulos**. Esto indica casi con certeza un origen urológico (no glomerular).
- **Conducta:**
 - 1. Estabilización hemodinámica si es necesario.

- 2. Instalación de sonda Foley de 3 vías para **lavado vesical continuo** (evitar el taponamiento por coágulos).
- 3. Solicitar **Uro-TAC con contraste** de forma urgente.
- 4. Evaluación inmediata por el especialista (**Urología**).

Resumen del Algoritmo de Estudio

- **Anamnesis y Examen Físico:** Buscar orientadores (dolor, fiebre, tabaco).
- **Sedimento y Urocultivo:**
 - - Si es ITU → Antibióticos.
 - - Si es Glomerular → Derivar a Nefrología.
- **Imágenes (Ecografía / Uro-TAC):** Buscar tumores o cálculos en riñón y uréter.
- **Cistoscopia:** Evaluación final de la vejiga (descarte de cáncer vesical).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Mnemotecnia para causas de hematuria (SIT): - Stone (Cálculos) - Infection (ITU/TBC) - Tumor (Vejiga, Riñón, Próstata)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de cuarenta y cinco años asintomático. Durante una ecografía abdominal realizada por otra causa se describe un quiste renal derecho de doce centímetros, sin pared ni septos en su interior. ¿Cuál es la conducta más adecuada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Quiste Renal Simple y Riñón Poliquístico. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El quiste renal simple es asintomático y se trata siempre con observación independientemente del tamaño; solo se opera si hay complicaciones demostradas causadas por el quiste
- Los quistes complejos se clasifican con Bosniak; Bosniak uno y dos se observan, Bosniak cuatro requiere cirugía por alto riesgo de malignidad
- El riñón poliquístico del niño tiene herencia autosómica recesiva y puede acompañarse de quistes hepáticos e hipoplasia pulmonar; el del adulto es autosómico dominante
- En el adulto, hematuria con masa renal bilateral hace sospechar riñón poliquístico; hematuria con masa unilateral hace sospechar cáncer renal
- El riñón poliquístico del adulto se asocia a aneurismas cerebrales; cefalea súbita intensa con vómitos en un paciente con riñón poliquístico debe hacer pensar en hemorragia subaracnoidea
- El riñón poliquístico es una enfermedad incurable que se maneja con soporte: control de la insuficiencia renal crónica, diálisis cuando corresponde, y trasplante renal como tratamiento definitivo de la falla renal
- El quiste renal simple se caracteriza por no tener pared, septos ni irregularidades internas; si tiene alguna de estas características es un quiste complejo

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (QUISTE RENAL SIMPLE Y RIÑÓN POLIQUÍSTICO)**PREGUNTA 1**

Paciente de cuarenta y cinco años asintomático. Durante una ecografía abdominal realizada por otra causa se describe un quiste renal derecho de doce centímetros, sin pared ni septos en su interior. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Nefrectomía parcial de urgencia porque el tamaño de doce centímetros hace sospechar malignidad
- B)** Drenaje del quiste por punción para reducir su tamaño y aliviar la presión
- C)** Observación, ya que el quiste renal simple se observa independientemente del tamaño
- D)** Biopsia por aguja fina para descartar malignidad por el gran tamaño del quiste
- E)** TAC con contraste urgente para clasificar el quiste según el riesgo de malignidad

PREGUNTA 2

Paciente de cincuenta y cinco años con riñón poliquístico del adulto conocido consulta a urgencias por cefalea de inicio súbito, muy intensa, cinco sobre diez, asociada a vómitos. No tiene trauma previo. ¿Cuál es el diagnóstico que hay que descartar con mayor urgencia?

- A)** Migraña severa por el antecedente de riñón poliquístico que se asocia a cefaleas frecuentes
- B)** Hipertensión arterial severa por la insuficiencia renal crónica del riñón poliquístico
- C)** Hemorragia subaracnoidea por rotura de aneurisma cerebral asociado al riñón poliquístico
- D)** Meningitis bacteriana por la inmunosupresión asociada a la insuficiencia renal crónica
- E)** Trombosis venosa cerebral por la policitemia que puede acompañar al riñón poliquístico

PREGUNTA 3

Hombre de cuarenta años con antecedente familiar de riñón poliquístico en su padre. Al examen físico se palpan masas renales bilaterales. Presenta hematuria macroscópica ocasional. ¿Cuál es la característica clínica que diferencia este cuadro del carcinoma de células renales?

- A)** La hematuria que está presente en el riñón poliquístico pero no en el carcinoma renal
- B)** Las masas renales bilaterales que orientan al riñón poliquístico versus la masa unilateral del cáncer renal
- C)** La fiebre que distingue al riñón poliquístico del carcinoma renal que no produce fiebre
- D)** El antecedente familiar que solo se ve en riñón poliquístico y no en el cáncer renal
- E)** La insuficiencia renal crónica que solo se ve en riñón poliquístico y no en el cáncer renal

RESUMEN: QUISTE RENAL SIMPLE Y RIÑÓN POLIQUÍSTICO

El quiste renal simple es una lesión benigna muy frecuente que se diagnostica como hallazgo incidental en imágenes. Clínicamente es asintomático. En la imagen se describe como una lesión quística sin pared, sin septos y sin irregularidades internas. El manejo es siempre observación independientemente del tamaño: un quiste de diez o quince centímetros se observa igual que uno pequeño. La única indicación de cirugía es que se complique con hemorragia, infección, obstrucción o dolor crónico, y solo si se demuestra que la complicación es causada por el quiste. Los quistes complejos con septos, paredes o irregularidades internas se clasifican según la escala de Bosniak: Bosniak uno y dos se observan, Bosniak cuatro requiere cirugía. El riñón poliquístico no es una sola enfermedad sino un grupo de enfermedades genéticas que se subdividen en riñón poliquístico del niño y del adulto. En niños las causas son múltiples, frecuentemente autosómicas recesivas, y pueden presentarse con quistes renales y hepáticos simultáneos, hipoplasia pulmonar e insuficiencia renal crónica. Se requiere estudio genético para definir el pronóstico. En adultos son predominantemente autosómicas dominantes con antecedente familiar frecuente. Clínicamente producen masas renales bilaterales palpables y hematuria, a diferencia del cáncer renal que produce masa unilateral. Se complican con insuficiencia renal crónica, sobreinfección, litiasis y hematuria. El riñón poliquístico del adulto se asocia a aneurismas cerebrales, por lo que en un paciente con riñón poliquístico que consulta por cefalea súbita e intensa con vómitos, hay que sospechar una hemorragia subaracnoidea. El tratamiento en ambas formas de riñón poliquístico es de soporte dado que son enfermedades incurables: manejo de las complicaciones de la insuficiencia renal crónica, diálisis cuando corresponde, y trasplante renal como tratamiento definitivo de la falla renal.